



COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA n.193.4/DT del 7 giu 2023

**Procedura Gestione Amministrativa delle Visite Mediche
e delle Prestazioni Sanitarie per il personale di Trenitalia**

Con la presente Comunicazione Organizzativa vengono ridefiniti i ruoli, le responsabilità e le modalità operative inerenti la gestione amministrativa delle visite mediche e delle prestazioni sanitarie per il personale di Trenitalia.

Inoltre, la presente Comunicazione Organizzativa aggiorna e sostituisce la CO n.193.3/DRUO del 09 ottobre 2018

FIRMATO
Marco Caposciutti

Procedura

Gestione Amministrativa delle Visite Mediche e delle Prestazioni Sanitarie per il personale di Trenitalia

*Nuova**Revisione Parziale**Revisione Totale*

x

Firma**Emanata da:** Direzione Tecnica

Marco CAPOSCIUTTI

Verificata da:

Responsabile DBR/Sistema Integrato Gestione Sicurezza, Qualità e Energia Regionale

Responsabile DBAV/Sistema Integrato Gestione Sicurezza, Qualità e Energia AV

Responsabile DBIC/Sistema Integrato Gestione Sicurezza, Qualità e Energia IC

Responsabile DT/Sistema Integrato Gestione Sicurezza, Qualità e Energia DT

Responsabile DT/Sistema Integrato Gestione Sicurezze e Qualità

Responsabile DRUO/Gestione del Personale e Contenzioso

Responsabile DRUO/Organizzazione e Processi

Approvata da:

Responsabile Direzione Risorse Umane e Organizzazione

Verifica di conformità con principi e regole di Gruppo:Responsabile FS SpA/Corporate Affairs/ Human Resources/ Organization & People
Development/Group Organisation**Data emissione:** 7 giu 2023**Data di decorrenza:** 7 giu 2023**Sostituisce:** CO n.193.3/DRUO del 09/10/2018

	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA n.193.4/DT del 7 giu 2023 Procedura Gestione Amministrativa delle Visite Mediche e delle Prestazioni Sanitarie per il personale di Trenitalia	DT Pagina 4 di 27
---	--	---

Tavola della Revisione		
N° REV.	Data	DESCRIZIONE
00	02 ago 2007	Prima emissione
01	17 giu 2011	– Ambito di applicazione delle visite mediche e delle prestazioni sanitarie per il personale di Trenitalia; – Gestione delle vaccinazioni antitetaniche e delle <u>visite mediche previste da normativa per il rilascio o il mantenimento di specifiche certificazioni tecnico/specialistiche non connesse direttamente con l'esercizio ferroviario</u> – Aggiornamento delle modalità di prenotazione delle visite mediche tramite l'applicativo VIME
02	13 gen 2012	– Aggiornamento a seguito dell'emanazione del D.Lgs n. 247/2010 "Attuazione della direttiva 2007/59/CE relativa alla certificazione dei macchinisti addetti alla guida di locomotori e treni sul sistema ferroviario della Comunità", e del Decreto ANSF n.8/2011 concernente "Licenze dei macchinisti addetti alla guida di locomotori e treni sul sistema ferroviario dell'Unione Europea".
03	9 ott 2018	– Aggiornamento a seguito recepimento Regolamento (UE) 2015/995 cui nota ANSF 00196/2017 e successive modifiche e integrazioni. – Adeguamento dei riferimenti alle strutture organizzative coinvolte.
04	7 giu 2023	– Aggiornamento dei ruoli incaricati all'attività di richiesta delle visite sanitarie – Aggiornamento dell'Allegato 1 – Recepimento <u>Legge di Bilancio 2019</u> (Legge n. 145 del 30 dicembre 2018) – Inserimento tabella contenente i Codici Esito delle visite sanitarie – Aggiornamento riferimenti normativi e organizzativi

	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA n.193.4/DT del 7 giu 2023 Procedura Gestione Amministrativa delle Visite Mediche e delle Prestazioni Sanitarie per il personale di Trenitalia	DT Pagina 5 di 27
---	---	--

INDICE

TAVOLA DELLA REVISIONE	4
INDICE	5
1. SCOPO E CONTENUTI DELLA PROCEDURA	6
3. DESCRIZIONE ITER PROCEDURALE.....	9
3.1 SOTTOPROCESSO 01 - INDIVIDUAZIONE SCADENZE VISITE E PREDISPOSIZIONE ELENCO.....	9
3.2 SOTTOPROCESSO 02 - PRENOTAZIONE VISITE MEDICHE.....	13
3.3 SOTTOPROCESSO 03 - EFFETTUAZIONE VISITE E RICEZIONE ESITI	20
3.4 SOTTOPROCESSO 04 - AGGIORNAMENTO DATI A SISTEMA E REPORTING	23
4. DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO.....	24
5. DEFINIZIONI E ABBREVIAZIONI	26
6. ALLEGATI.....	27

	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA n.193.4/DT del 7 giu 2023 Procedura Gestione Amministrativa delle Visite Mediche e delle Prestazioni Sanitarie per il personale di Trenitalia	DT Pagina 6 di 27
---	--	---

1. Scopo e Contenuti della Procedura

Obiettivo della presente procedura è la definizione delle responsabilità, dei criteri e delle modalità operative per la gestione delle visite mediche e delle prestazioni sanitarie del personale di Trenitalia, con particolare riguardo:

- ai flussi di comunicazione tra gli attori coinvolti nelle fasi di programmazione ed effettuazione delle visite mediche e delle prestazioni sanitarie;
- all’ottimizzazione del processo di invio a visita del personale in relazione alle esigenze di produzione dell’impianto/struttura di appartenenza;
- alle modalità di monitoraggio e controllo del processo di gestione delle visite medico-legali di revisione effettuate ai sensi del D.Lgs n. 247/2010 “Attuazione della direttiva 2007/59/CE” e del Decreto ANSF n. 8/2011, ai sensi del punto 4.7 del Regolamento (UE) 2019/773 (già punto 4.7 del Regolamento (UE) 2015/995), delle note ANSF n.196/2017 e n.10338/2017, e, per i casi ancora previsti, ai sensi della Disposizione RFI 55/2006 e s.m.i. tenuto conto delle indicazioni contenute nella nota ANSFISA n.0059345.23-12-2022, recepita con nota DT TRNIT-DTP\P\2023\00190227 del 13/03/2023;
- alle modalità di monitoraggio e controllo del processo di gestione delle visite mediche di sorveglianza sanitaria effettuate ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.

Sono oggetto della procedura:

- **le visite mediche di sorveglianza sanitaria e gli eventuali accertamenti sanitari resi necessari a seguito di valutazione dei rischi da parte del Datore di Lavoro, effettuate ai sensi dell’art. 41 del D.Lgs 81/08 e s.m.i.** per tutto il personale di Trenitalia, ivi compreso il personale di cui alla CO 348/DRUO r.v.;
La sorveglianza sanitaria ai sensi del Dlgs 81/08 comprende tutti gli accertamenti specialistico-strumentali dei protocolli sanitari stabiliti dal Medico competente e viene effettuata sulla scorta dei dati trasmessi, caso per caso, con la scheda dei dati occupazionali. Tale scheda viene compilata in ogni sua parte a cura del Datore di Lavoro o da suo incaricato, firmata anche dal lavoratore e trasmessa al Medico competente per essere poi inserita in cartella sanitaria di rischio del lavoratore a cura del Medico stesso;
- **le visite mediche di revisione/controllo/idoneità/assegnazione/attribuzione/abilitazione** per il personale di Trenitalia impiegato in attività di sicurezza dell’esercizio ferroviario: Condotta, Accompagnamento dei Treni, Preparazione dei Treni, Manutenzione Veicoli, in recepimento e applicazione:
 - del D.Lgs n. 247/2010 - Decreto ANSF n. 8/2011 concernente "Licenze dei macchinisti addetti alla guida di locomotori e treni sul sistema ferroviario dell'Unione Europea";
 - del punto 4.7 del Regolamento (UE) 2019/773 (già punto 4.7 del Regolamento (UE) 2015/995);
 - della nota ANSF n. 000196/2017 del 10/01/2017 – “Attuazione dei punti 4.6 e 4.7 della Specifica Tecnica di Interoperabilità Esercizio e Gestione del Traffico emanata in allegato alla decisione 2012/757/UE e modificata dal Regolamento (UE) 2015/995 della Commissione dell'8 giugno 2015. Adozione dei principi introdotti dalla Specifica Tecnica di Interoperabilità Esercizio anche nelle norme nazionali” e successive modifiche e integrazioni;
 - della nota ANSF n. 0010338/2017 del 27/09/2017: “Modifiche alle norme nazionali, indicazioni e chiarimenti per l'invio a visita medica e per la certificazione dei requisiti. Applicazione della nota ANSF 196/ 2017 del 10/01/2017 "Attuazione dei punti 4.6 e 4.7 della Specifica Tecnica di Interoperabilità Esercizio e Gestione del traffico emanata in allegato alla decisione 2012/757/UE e modificata dal Regolamento (UE) 2015/ 995 della Commissione dell'8 giugno 2015. Adozione dei principi introdotti dalla Specifica Tecnica di Interoperabilità Esercizio anche nelle norme nazionali”;
 - della nota ANSF n. 002161/2014 del 24/03/2014: “Scadenza visite sanitarie ai sensi del D.Lgs. 247/2010”;
 - della nota ANSFISA n. 0028455/ 2021 del 09/12/2021: “Certificazione medico-legale dell'idoneità psico-fisica allo svolgimento di attività di sicurezza della circolazione ferroviaria”;

- della Disposizione RFI 55/2006 - “Norme relative alle visite mediche per l’assunzione e la revisione del personale utilizzato in attività connesse con la Sicurezza della circolazione dei treni e dell’esercizio ferroviario”, per i casi previsti;
 - della nota ANSFISA n.0059345.23-12-2022 “Equiparazione dei requisiti fisici speciali della Disposizione RFI 55/2006 tra visita di assunzione e visita di revisione – Ulteriore estensione dei principi introdotti nella normativa europea per la “Condotta dei treni” e l’“Accompagnamento dei treni” alle altre attività di sicurezza”, recepita con nota DT TRNIT-DTP\P\2023\00190227 del 13/03/2023;
- **le visite non programmabili ovvero gli accertamenti sanitari che non sono prevedibili e che non derivano da una scadenza definita da un dettato normativo;**
 - **le vaccinazioni antitetaniche effettuate ai sensi della Legge n. 292 del 5 marzo 1963, Legge n. 419 del 20/03/1968 e del DM 22 marzo 1975,** per tutto il personale di esercizio di Trenitalia che svolge attività di sicurezza dell’esercizio ferroviario: Condotta, Accompagnamento dei Treni, Preparazione dei Treni, Manutenzione Veicoli;
 - **le visite mediche previste da normativa per il rilascio o il mantenimento di specifiche certificazioni tecnico/specialistiche non connesse direttamente con l’esercizio ferroviario,** per il personale di Trenitalia incaricato allo svolgimento di particolari attività o addetti all’utilizzo/gestione di particolari attrezzature/impianti.

A titolo esemplificativo non esaustivo, è prevista una visita medica per la verifica dell’idoneità fisica o psico-fisica per le seguenti attività:

Attività	Tipo di visita necessaria	Periodicità	Riferimento normativo
Controlli non distruttivi: - metodo ultrasuoni - magnetoscopico - liquidi penetranti	Visita medica idoneità controlli non distruttivi (verifica requisiti di acutezza visiva e senso cromatico)	Annuale	- UNI EN ISO 9712 - DoP 43/DT-SIGSQ r.v. - Specifica Trenitalia n. 308177 r.v.
Condotta caldaie a vapore delle Centrali Termiche (qualsiasi tipologia)	Visita medico competente per idoneità conduzione generatori di vapore	Quinquennale (biennale per chi ha compiuto 60 anni)	- DM 07/08/2020 art. 1 comma 2 - D.Lgs 81/2008 art. 41

La corretta gestione del processo consente di:

- definire un’applicazione omogenea trasversale a tutte le strutture di Trenitalia SpA;
- definire le responsabilità delle strutture coinvolte nelle fasi del processo;
- attivare con tempestività il piano delle visite medico-legali di revisione/controllo/idoneità/assegnazione /attribuzione/abilitazione e delle visite mediche di sorveglianza sanitaria ai sensi del D.Lgs. 81/08;
- dare attuazione alle norme comportamentali contenute nel Codice Etico del Gruppo FS Italiane, con particolare riferimento al paragrafo 5.4: “Rapporto con le Persone del Gruppo”;
- dare attuazione a quanto previsto in materia dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dalla Società ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA n.193.4/DT del 7 giu 2023 Procedura Gestione Amministrativa delle Visite Mediche e delle Prestazioni Sanitarie per il personale di Trenitalia	DT Pagina 8 di 27
---	---	---

2. Strutture e Soggetti

Strutture di Trenitalia

- Unità Produttive Trenitalia
- Struttura Dirigenziale Territoriale (SDT)
- Direzione Risorse Umane e Organizzazione
 - Gestione del Personale e Contenzioso (GPC)
 - Strutture di RU Territoriali (RUT)

Strutture di Gruppo

Corporate Affairs (COA di FS SpA)

HUR/PMC /Gestione

Società del Gruppo

RFI

- Direzione Sanità/Unità Sanitarie Territoriali (UST) e loro Presidi sanitari

Soggetti

- Datore di Lavoro (DdL)
- Responsabile Servizi Prevenzione e Protezione (RSPP)
- Addetto del Servizio di Prevenzione e Protezione (ASPP)
- Responsabile di Impianto (RdI)
- Incaricato della prenotazione delle visite sanitarie sul sistema VIME
- Dirigente Responsabile di struttura organizzativa (DR)
- Dipendente Trenitalia
- Funzionario medico di Direzione Sanità/Unità Sanitarie Territoriali (UST) e loro Presidi sanitari con competenze valutative in ambito medico-legale e di medicina del lavoro (in quest'ultimo caso individuabile come Medico Competente - MC)
- Psicologo di Direzione Sanità/Unità Sanitarie Territoriali (UST) e loro Presidi sanitari
- Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture Stradali ed Autostradali (ANSFISA)
- Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente (ASL)

	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA n.193.4/DT del 7 giu 2023 Procedura Gestione Amministrativa delle Visite Mediche e delle Prestazioni Sanitarie per il personale di Trenitalia	DT Pagina 9 di 27
---	--	---

3. Descrizione Iter Procedurale

3.1 Sottoprocesso 01 - Individuazione scadenze visite e predisposizione elenco

Unità Organizzative Responsabili e Ruoli Coinvolti	– Datore di Lavoro (DdL) – Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP) – Responsabile d’Impianto (RdI) Dirigente Responsabile di struttura organizzativa (DR) – RFI/Direzione Sanità/Unità Sanitarie Territoriali (UST) e loro Presidi sanitari/ Funzionario medico di Direzione Sanità/Unità Sanitarie Territoriali (UST) e loro Presidi sanitari con competenze valutative in ambito medico-legale e di medicina del lavoro (in quest’ultimo caso individuabile come Medico Competente - MC)/Psicologo di Direzione Sanità/Unità Sanitarie Territoriali (UST) e loro Presidi sanitari nelle fattispecie previste
Sottoprocesso 1.A: personale Trenitalia in possesso di abilitazione per le attività di sicurezza dell’esercizio ferroviario: Entro il 5 settembre di ogni anno, e ogni qualvolta ci siano delle variazioni a seguito dell’aggiornamento della valutazione dei rischi, il RSPP, con la collaborazione del MC: – compila/aggiorna i nominativi dei lavoratori da sottoporre alle visite di sorveglianza sanitaria, ai sensi dell’art. 41 del D.Lgs. 81/08, nella scheda “Elenco nominativi del personale da inviare a visita medica” (Allegato 1), con la collaborazione del relativo RdI, indicando la tipologia di rischio (completa delle ulteriori informazioni come indicato nelle istruzioni di compilazione riportate nell’allegato 1) e la data entro cui effettuare la visita in funzione della periodicità stabilita dal MC durante le visite precedenti, evidenziando i nominativi dei lavoratori da inviare a sorveglianza sanitaria entro l’anno successivo; – invia l’allegato 1 al RdI entro il suddetto termine. il RdI: • Entro il 10 settembre di ogni anno, – individua i nominativi dei lavoratori in possesso di abilitazioni di sicurezza (escluso Condotta), da sottoporre a visita di revisione indicando la data di scadenza revisionale ai sensi della nota ANSF n. 10338/2017, e le attività di sicurezza cui è impiegato il dipendente da sottoporre alla visita di revisione; – individua i nominativi del personale di condotta in possesso di Licenza comunitaria rilasciata di cui COCS n. 46/DT r.v. da sottoporre a visita di revisione con le modalità previste dal Decreto ANSF n. 8/2011 e nota ANSF n. 2161/2014; – individua i nominativi del personale in possesso di abilitazioni interne Patente A*, MI/A e MI/B di cui alla DOCS 55/DT-SIGSQ r.v.; – individua i nominativi del personale in possesso di abilitazioni settore Manutenzione Veicoli di cui alla COCS n. 20/DT r.v.; – verifica la scheda “Elenco nominativi del personale da inviare a visita medica” (Allegato 1), fornitagli dal RSPP; – integra la scheda “Elenco nominativi del personale da inviare a visita medica” (Allegato 1): • con l’elenco dei nominativi del personale da sottoporre, nel corso dell’anno successivo, alla visita medica di revisione; • con l’elenco dei nominativi dei lavoratori da sottoporre a vaccinazione antitetanica, indicando il tipo di vaccinazione e la data entro cui effettuarla, evidenziando quelli per i quali risulti una scadenza entro l’anno successivo;	

- con l'elenco dei nominativi dei lavoratori da sottoporre a visite mediche per il conseguimento/mantenimento di certificazioni tecnico/specialistiche non connesse direttamente con l'esercizio ferroviario evidenziando quelli per i quali risulti una scadenza entro l'anno successivo;
- invia l'allegato 1 al DdL dell'Unità Produttiva (UP) di competenza o suo delegato.

La scheda "Elenco nominativi del personale da inviare a visita medica" deve essere richiamata all'interno del DVR.

Sottoprocesso 1.B: personale Trenitalia impiegato in ruoli con impatto sulla sicurezza di esercizio ferroviario

Entro il 5 settembre di ogni anno, e ogni qualvolta ci siano delle variazioni a seguito dell'aggiornamento della valutazione dei rischi, il RSPP, con la collaborazione del MC:

- compila/aggiorna i nominativi dei lavoratori da sottoporre alle visite di sorveglianza sanitaria, ai sensi dell'art. 41 del D.Lgs. 81/08, nella scheda "Elenco nominativi del personale da inviare a visita medica" (Allegato 1), con la collaborazione del relativo RdI, indicando la tipologia di rischio (completa delle ulteriori informazioni come indicato nelle istruzioni di compilazione riportate nell'allegato 1) e la data entro cui effettuare la visita in funzione della periodicità stabilita dal MC durante le visite precedenti, evidenziando i nominativi dei lavoratori da inviare a sorveglianza sanitaria entro l'anno successivo;
Rientrano in tale fattispecie i lavoratori impiegati in ruoli previsti dalla CO n. 348/DRUO r.v. che esercitano, secondo linea gerarchica, coordinamento e controllo sull'organizzazione del servizio e del personale impegnato in una o più attività di sicurezza (Responsabili di Impianto, Distributori del servizio), nonché il personale impiegato in attività proprie dei ruoli delle Sale Operative (Responsabile Sala Operativa, Coordinatore Sala Operativa, Gestore Mezzi/Materiale trainato). Tale personale deve essere soltanto sottoposto alle visite mediche di sorveglianza sanitaria ai sensi del D.Lgs. 81/08, salvo il caso in cui sia in possesso di abilitazioni di sicurezza in corso di validità. Qualora il personale suddetto sia in possesso di abilitazioni di sicurezza in corso di validità si applica il precedente sottoprocesso 1.A.
- invia l'allegato 1 al RdI entro il suddetto termine.

il RdI:

- Entro il 10 settembre di ogni anno,
 - verifica la scheda "Elenco nominativi del personale da inviare a visita medica" (Allegato 1), fornitagli dal RSPP;
 - invia l'allegato 1 al DdL dell'Unità Produttiva (UP) di competenza o suo delegato.

La scheda "Elenco nominativi del personale da inviare a visita medica" deve essere richiamata all'interno del DVR.

Sottoprocesso 1.C: personale Trenitalia non impiegato in mansioni connesse con la sicurezza di esercizio ferroviario

Entro il 5 settembre di ogni anno, e comunque ogni qualvolta ci siano delle variazioni a seguito dell'aggiornamento della valutazione dei rischi, il RSPP, con la collaborazione del MC:

- compila/aggiorna i nominativi dei lavoratori da sottoporre alle visite di sorveglianza sanitaria, ai sensi dell'art. 41 del D.Lgs. 81/08, nella scheda "Elenco nominativi del personale da inviare a visita medica" (Allegato 1), con la collaborazione del relativo RdI/DR, indicando la tipologia di rischio (completa delle ulteriori informazioni come indicato nelle istruzioni di compilazione riportate nell'allegato 1) e la data entro cui effettuare la visita in funzione della periodicità stabilita dal MC durante le visite precedenti, evidenziando i nominativi dei lavoratori da inviare a sorveglianza sanitaria entro l'anno successivo;
- invia l'allegato 1 al RdI/DR entro il suddetto termine.

Entro il 10 settembre di ogni anno,

il RdI/DR:

- verifica l'allegato 1 e lo integra, *per il solo personale impiegato in attività connesse alla manutenzione dei rotabili*, con i nominativi dei lavoratori da sottoporre a vaccinazione antitetanica, indicando il tipo di vaccinazione e la data entro cui effettuarla, ed evidenzia quelli per i quali risulta una scadenza entro l'anno successivo;
- integra la scheda "Elenco nominativi del personale da inviare a visita medica" (Allegato 1) con l'elenco dei nominativi dei lavoratori da sottoporre a visite mediche per il conseguimento/mantenimento di certificazioni tecnico/specialistiche non connesse direttamente con l'esercizio ferroviario, evidenziando quelli per i quali risulti una scadenza entro l'anno successivo;
- invia l'allegato 1 al DdL dell'UP di competenza o suo delegato.

La scheda "Elenco nominativi del personale da inviare a visita medica" deve essere richiamata all'interno del DVR.

Entro il 30 settembre il DdL trasmette, per il tramite delle risorse incaricate alla prenotazione delle visite mediche, alle Unità Sanitarie Territoriali/Presidi sanitari della Direzione Sanità di RFI SpA (UST e loro Presidi), la pianificazione del numero delle visite da effettuare nell'anno successivo, ovvero un estratto numerico derivante dall'Allegato 1 con la distinzione tra le visite di medicina legale e le visite di medicina del lavoro, al fine di fornire i volumi di massima circa il quantitativo di visite necessarie (*vedi foglio "Riepilogo_LA_LE" all'interno dell'Allegato 1*).

I codici da inserire nel sistema VIME relativi alle tipologie e ai motivi visita da prenotare sono indicati nell'Allegato 1, corredato da apposito vademecum suddiviso per ambito normativo di riferimento periodicamente sottoposto a revisione.

Individuazione degli incaricati e gestione del periodo transitorio

Per tutte le casistiche sopra menzionate, il DdL individua e incarica per l'UP di competenza una o più risorse per l'effettuazione della prenotazione delle visite mediche tramite il sistema informatico VIME, come interfaccia operativa verso le competenti Unità Sanitarie Territoriali della Direzione Sanità di RFI SpA (UST). Il DdL deve garantire per tali risorse la formazione preventiva sul processo e sull'utilizzo di VIME e formalmente incaricarle attraverso l'apposita "Tile" presente sul Portale WE assicurando la continuità operativa del processo di gestione delle visite.

L'attività di prenotazione delle Visite Sanitarie sul sistema VIME sarà assegnata agli incaricati dai DdL a seguito di intervento formativo dedicato a cura di DRUO.

A valle dell'erogazione dell'intervento formativo saranno rilasciate le utenze e gli incaricati saranno abilitati per procedere in autonomia.

La formazione sarà terminata entro il 30/06/2023 e pertanto durante il periodo transitorio utile al completamento della formazione e al rilascio delle utenze, l'attività di prenotazione delle visite sanitarie sarà assicurata da DRUO in continuità con quanto in essere.

Raccomandazioni in materia di protezione dei dati personali

Per assicurare il rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali vigente, ai sensi del Reg. UE 679/2016 (GDPR) e del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., è necessario porre in essere alcuni importanti adempimenti. La risorsa addetta ad operare sul sistema VIME per l'inserimento della richiesta di visita medica o che più in generale tratta dati personali dei dipendenti per la gestione del processo disciplinato dalla presente CO, deve essere preventivamente designata incaricata del trattamento dal data manager di Trenitalia. Inoltre la richiesta di prenotazione della visita medica

deve contenere i dati personali del dipendente da visitare strettamente necessari per tale finalità (per es. nome, cognome e data di nascita).

Laddove sia previsto l'invio di file contenenti dati personali dei dipendenti soggetti a visita medica, tale trasmissione deve avvenire adottando idonee misure di sicurezza a protezione dei dati (es. cifratura; uso di password da inviare con mail separata).

Conformemente a quanto previsto dalla C.O.I. /AD n. 25 del 5 ago 2021, deve essere evitato, per quanto possibile, l'utilizzo di supporti cartacei per il trattamento di dati personali, preferendo le attività di trattamento e l'archiviazione di dati in formato elettronico. Pertanto, salvo diverse esigenze aziendali o specifiche previsioni normative, si raccomanda di conservare il registro delle visite mediche/vaccinazioni in formato digitale. In particolare, lo stesso deve essere archiviato su cloud aziendale (es. One Drive, Teams, ecc) e reso consultabile, con perimetrazione dei con di visibilità, esclusivamente ai dipendenti strettamente necessari, designati incaricati dal Data Manager competente di Trenitalia.

Controlli Chiave L.262/2005	N.A.
Controlli Chiave D.Lgs. 231/2001	<i>Cod. H: Gestione degli aspetti connessi alla salute e sicurezza sul lavoro</i>
Anticorruzione Strumenti di prevenzione	<u>Policy Anticorruzione</u> Area Sensibile: <i>"Selezione, assunzione, gestione e sviluppo del Personale"</i> <u>ABC System Management</u> Processo: <i>"Risorse Umane"</i>

	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA n.193.4/DT del 7 giu 2023 Procedura Gestione Amministrativa delle Visite Mediche e delle Prestazioni Sanitarie per il personale di Trenitalia	DT Pagina 13 di 27
---	--	--

3.2 Sottoprocesso 02 - Prenotazione visite mediche

<i>Unità Organizzative Responsabili e Ruoli Coinvolti</i>	– DRUO/Gestione del Personale e Contenzioso (GPC) – DRUO/Strutture di Risorse Umane Territoriali (RUT) – DT/SIGSQ – Datore di Lavoro (DdL) – Delegato del Datore di Lavoro – Impianto/Responsabile di Impianto (RdI) – Dirigente Responsabile di struttura organizzativa (DR) – Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP) – Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione (ASPP) – Incaricato della prenotazione delle visite sanitarie sul sistema VIME – Dipendente Trenitalia – RFI/Direzione Sanità/Unità Sanitarie Territoriali (UST) e loro Presidi sanitari/ Funzionario medico di Direzione Sanità/Unità Sanitarie Territoriali (UST) e loro Presidi sanitari con competenze valutative in ambito medico-legale e di medicina del lavoro (in quest'ultimo caso individuabile come Medico Competente -MC -)/Psicologo di Direzione Sanità/Unità Sanitarie Territoriali (UST) e loro Presidi sanitari nelle fattispecie previste – Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture Stradali ed Autostradali (ANSFISA) – Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente (ASL)
<i>Descrizione</i>	Entro la fine di ogni mese il DdL o il RdI/DR, per il tramite delle risorse incaricate della prenotazione delle visite mediche, individua attraverso la scheda “Elenco nominativi personale da inviare a visita medica” (Allegato 1), la: – lista dei dipendenti da sottoporre a visita di revisione/controllo/ idoneità/assegnazione/attribuzione/abilitazione e/o sorveglianza sanitaria il 3° mese successivo; – lista dei dipendenti da sottoporre a visita medica entro il 3° mese successivo per il conseguimento/mantenimento di certificazioni tecnico/specialistiche non connesse direttamente con l'esercizio ferroviario; indicando le date prescelte/previste per la visita e: – la tipologia di rischio per la quale effettuare la visita per le visite mediche di sorveglianza ai sensi del D.Lgs. 81/08, <u>(completa delle informazioni relative ai livelli di esposizione al rischio</u> e tutte le altre indicate nelle istruzioni di compilazione riportate nell'allegato 1); – l'attività di sicurezza cui è impiegato il dipendente da sottoporre alla visita di revisione per le visite di revisione/controllo idoneità/assegnazione/attribuzione/abilitazione; – la tipologia di visita per le visite mediche per il conseguimento/mantenimento di certificazioni tecnico/specialistiche non connesse direttamente con l'esercizio ferroviario. A seguito delle visite di cui sopra, per garantire il rispetto delle eventuali scadenze prescritte dal medico per successive visite di controllo, il <u>DdL o il RdI/DR</u> effettua tempestivamente la prenotazione sul sistema VIME per il tramite della risorsa incaricata, appena venuto a conoscenza di tali termini. Il programma visite da svolgere:

- ai sensi della Disposizione n. 55/2006 di RFI e s.m.i. e della Nota n. 10338/2017 ANSF smi deve essere redatto pianificando la data di effettuazione di ciascuna visita con un anticipo di almeno 30 giorni rispetto alla relativa scadenza, in modo da garantire il ricevimento della certificazione sanitaria entro tale termine;
- per gli abilitati alla Condotta ai sensi del D.Lgs. 247/2010-Decreto n. 8/2011 ANSF, deve essere redatto pianificando la data di effettuazione di ciascuna visita almeno 45 giorni prima della relativa scadenza, in modo da garantire il ricevimento della certificazione sanitaria entro tale termine.

Nell'intento comune e più generale di contenimento dei costi, è opportuno che il DdL o il RdI/DR preveda che il dipendente che debba sottoporsi nel corso dello stesso anno a più visite mediche, le svolga nella stessa data.

La precedente indicazione non si applica nei casi di visite mediche atte ad escludere una condizione di alcol dipendenza o alla verifica di assenza di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti per cui valgono i requisiti previsti dalla CO n.457/DT r.v. "Tutela della salute e della sicurezza rispetto al consumo di sostanze alcoliche e psicotrope per il personale di Trenitalia". Per tali visite devono infatti essere garantite le caratteristiche di non prevedibilità da parte dei lavoratori della data di effettuazione dell'accertamento.

E' possibile continuare a pianificare nella stessa data più visite, tra cui quelle atte ad escludere una condizione di alcol dipendenza o alla verifica della non assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti, per il solo personale non direttamente connesso con la sicurezza della circolazione ferroviaria, ad es. gli "addetti alla guida di macchine di movimentazione terra e merci" (addetti ai carrelli elevatori) o "tutte le mansioni che prevedono attività in quota oltre i due metri di altezza" (per la sola alcol dipendenza), se e solo se i criteri, adottati per la pianificazione della data delle visite mediche, garantiscano l'imprevedibilità da parte del personale interessato della data o del periodo dell'anno in cui si svolgeranno tali visite".

La richiesta di prenotazione di visita medica dovrà essere effettuata presso la UST/ Presidio sanitario dal MC in riferimento alla sede lavorativa del dipendente.

Relativamente ai controlli on site di cui alla CO n.457/DT r.v. e COCS n.57 /DT r.v. il DdL o il RdI/DR prendono contatto entro il 10 settembre con l'UST/Presidio sanitario competente al fine di concordare le modalità e una prima programmazione per l'effettuazione dell'attività di controllo on-site; tale programmazione annuale sarà comunicata anche a DRUO/Gestione del Personale (email: prestazionisanitarie@trenitalia.it). Nel corso dell'anno successivo la suddetta programmazione dovrà essere monitorata dal DdL o RdI/DR, con periodicità mensile, al fine di garantire l'obiettivo di effettuazione dei controlli nelle percentuali indicate nella CO n.457/DT r.v. e COCS n.57/DT r.v..

La richiesta di prenotazione di tali controlli on-site non avviene tramite VIME ma viene comunicata tramite mail e viene consuntivata a sistema dal medico della UST che ha effettuato la prestazione.

Qualora il lavoratore dovesse svolgere la propria attività presso impianto diverso da quello di appartenenza, la gestione della prenotazione delle visite rimane in capo al DdL di appartenenza. In caso di utilizzo continuativo presso altro impianto, la visita, d'accordo con la UST/Presidio sanitario dell'impianto di appartenenza, potrà essere svolta presso la UST dell'Impianto utilizzatore.

È cura del DdL utilizzatore del lavoratore accertarsi che tutte le scadenze delle visite programmate siano state effettivamente rispettate.

Per le scadenze delle visite sanitarie di cui alla Disposizione n. 55/2006 di RFI e s.m.i. ed alla Nota n. 10338/2017 ANSF smi e, per gli abilitati alla Condotta, di cui al D.Lgs. 247/2010-Decreto n.8/2011 ANSF, compete al RdI di utilizzazione, con il supporto del GVM (Gestore delle Visite Mediche) di cui alla COCS 41/DT r.v., monitorare le scadenze delle visite sanitarie ed interfacciarsi con il RdI di appartenenza che provvederà per l'invio a visita.

Almeno 20 giorni prima della data della visita

La risorsa incaricata alla prenotazione delle visite mediche, per conto del DdL o il RdI/DR, effettua la richiesta di prenotazione delle visite secondo le scadenze prestabilite, presso la competente UST/Presidio sanitario, utilizzando l'apposito applicativo immettendo i nominativi, la tipologia visita, il motivo visita e la relativa data di presentazione:

- *nel caso di visite di medicina legale* predispone la lettera di convocazione generata da VIME e la invia via mail al RdI/DR e al lavoratore;
- *nel caso di visite di medicina del lavoro, ai sensi del D.Lgs 81/08 e s.m.i.*, predispone la scheda dati occupazionali e dopo aver raccolto la firma del DdL/Delegato DdL o del RdI/DR, la consegna al dipendente per la successiva presentazione presso la UST/MC in sede di visita medica ed archiviazione nella cartella sanitaria di rischio;
- *nel caso la prenotazione della visita medica preveda i controlli per le sostanze psicotrope e stupefacenti, esclusi i controlli on-site a campione*, invia la lettera di convocazione prodotta dal sistema VIME al DdL-RdI/DR o il personale da lui delegato che provvede a consegnarla/inviarla via mail al dipendente con preavviso di non più di un giorno dalla data stabilita per l'accertamento.
- *solo nel caso di vaccinazione antitetanica da effettuarsi presso le UST di Direzione Sanità di RFI*, predispone la lettera di convocazione generata da VIME, raccoglie la firma del RdI/DR e la consegna al dipendente per la successiva presentazione alla UST/Presidio sanitario in sede di visita (vedi anche paragrafo 3.2.1.3 Vaccinazioni antitetaniche)

In caso la visita non venisse accettata e confermata da VIME, la/le risorse incaricate alla prenotazione delle visite mediche provvederanno a concordare con la UST/Presidio sanitario le date utili, d'intesa con il RdI/DR o con il DdL interessato, per giungere, secondo le scadenze prestabilite, alla definitiva prenotazione.

Nel caso si verifichi l'esigenza di modificare la data della visita prenotata, da parte del RdI/DR o del DdL o dell'UST, le parti si attiveranno per prenotare una data alternativa alla precedente come nel caso di prenotazione di visite non programmabili sotto-descritto.

3.2.1 Visite non Programmabili:**3.2.1.1 Visite non programmabili gestite amministrativamente a cura delle funzioni HR*****a) Richiesta di visita superiore da parte del lavoratore per appello al giudizio espresso alla visita di medicina Legale:***

L'eventuale richiesta di visite superiori pervenuta dal dipendente per non accettazione del giudizio idoneativo medico-legale, deve essere raccolta dal Datore di Lavoro per il tramite del RdI/DR ed inviata al RUT competente. Nelle more di implementare nel sistema informatico VIME per consentire la richiesta di tale prestazione alla stregua delle altre visite sanitarie, il RUT trasmette l'istanza all'indirizzo di posta rfi-dposa.mil@pec.rfi.it della Struttura centrale di Medicina Legale di Direzione Sanità che definisce data e orario della visita. Dopo aver ricevuto la lettera di convocazione il RUT la invia al dipendente e informa il DdL/ RdI/DR.

b) Richiesta di flessibilità del congedo di maternità pre-parto (Art.20 D.lgs.151/2001 e Art 33, punto 1.3, CCNL Mobilità/Area AF)

La lavoratrice che decide di avvalersi del congedo di maternità flessibile ovvero di un mese prima e 4 dopo il parto oppure nei 5 mesi successivi al parto ,deve acquisire un certificato del medico del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato avallato dal medico competente in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro nel quale certifichino l'assenza di rischio alla salute della lavoratrice e alla corretta prosecuzione della gravidanza, ed inoltrare la domanda ad INPS tramite i canali in uso.

La lavoratrice deve presentare la domanda all'INPS entro il 7° mese e a tal fine deve informare il DdL/RdI/DR e richiedere nei tempi utili a DRUO/GPC o RUT competente la prenotazione della visita con il medico competente ai Sensi del D.Lgs. 151/2001, così come integrato dall'articolo 1 comma 485 della Legge 145 del 30 dicembre 2018.

DRUO/GPC o RUT competente, dopo aver ricevuto la richiesta dalla lavoratrice, inserisce la prenotazione della visita nel sistema VIME, invia alla dipendente la scheda dati occupazionali e informa il Ddl/ RdI/DR

c) Visite sanitarie necessarie per il ricollocamento del personale/cambio attività lavorativa (es: a seguito di esito di inidoneità o idoneità con limitazioni/prescrizioni)

Qualora il processo di ricollocamento del personale inidoneo ad un'attività di sicurezza prevede l'assegnazione in un'altra attività di sicurezza , il RUT competente prima di formalizzare il provvedimento, d'intesa con il Responsabile della struttura di destinazione, richiede alla UST/Presidio sanitario di riferimento la/le visita/e sanitaria necessaria/e ad accertare il possesso dei requisiti fisici /psicologici richiesti dalla normativa di riferimento per il nuovo profilo/attività di sicurezza.

d) Visita di inabilità assoluta e permanente a qualsiasi attività lavorativa (dipendenti iscritti al Fondo Speciale Ferrovie dello Stato S.P.A.)

Il personale in servizio, iscritto al Fondo Speciale Ferrovie dello Stato S.p.A, qualora ritenga di essere nelle condizioni per aver titolo alla pensione di inabilità di cui all'art. 2, comma 12 della L. n. 335/95, deve rivolgersi a DRUO/GPC o RUT competente per l'istruzione della domanda, che dovrà essere redatta secondo lo schema di cui all'allegato 1 del DM n.187/1997. Tale domanda viene trasmessa da DRUO/GPC o RUT competente alla sede INPS Polo Fondo Speciale FS competente, che procederà alla richiesta della visita collegiale alla Direzione Sanità/UST/Presidio sanitario di RFI S.p.A. A seguito della visita collegiale, Direzione Sanità/UST/Presidio sanitario di RFI provvederà a redigere il Verbale con il giudizio medico-legale in ordine alla sussistenza dei presupposti medici per la concessione o meno del beneficio. L'esito della visita collegiale verrà inviato dalla Direzione Sanità/UST/Presidio sanitario alla sede INPS con diagnosi omessa, all'interessato con diagnosi in chiaro e a DRUO/GPC e/o RUT competente con diagnosi omessa, che provvederà a predisporre il provvedimento di cessazione del rapporto di lavoro, da allegare alla domanda di pensione di inabilità.

e) Visita di inidoneità al servizio ferroviario in genere (dipendenti iscritti al Fondo Speciale Ferrovie dello Stato S.P.A.)

Il personale in servizio, iscritto al Fondo Speciale Ferrovie dello Stato S.p.A, qualora ritenga di essere nelle condizioni di gravità di salute per aver titolo alla pensione di inidoneità a qualsiasi mansione ferroviaria, deve rivolgersi a DRUO/GPC o RUT competente, trasmettendo apposita richiesta in forma scritta con apposizione della data e firma autografa ovvero tramite email aziendale.

DRUO/ GPC o RUT competente, verificati i requisiti minimi di iscrizione assicurativa al Fondo Speciale presso INPS, ovvero l'anzianità contributiva di almeno dieci anni, trasmette la richiesta alla sede INPS Polo Fondo Speciale FS competente che procederà alla richiesta della visita collegiale alla Direzione Sanità/UST/Presidio sanitario di R.F.I.

S.p.A. A seguito della visita collegiale, Direzione Sanità/UST/Presidio sanitario di RFI provvederà a redigere il Verbale con il giudizio medico-legale in ordine alla sussistenza dei presupposti medici per la concessione o meno del beneficio. L'esito della visita collegiale verrà inviato dalla Direzione Sanità/UST/Presidio sanitario alla sede INPS con diagnosi omessa, all'interessato con diagnosi in chiaro e a DRUO/GPC o RUT competente con diagnosi omessa, che provvederà a predisporre il provvedimento di cessazione del rapporto di lavoro, da allegare alla domanda di pensione di inidoneità alle attività ferroviarie.

In linea generale, oltre ai suddetti casi A), B), C), D), E), DRUO/GPC o RUT competente si occupa della richiesta e gestione amministrativa degli accertamenti sanitari il cui esito può determinare l'applicazione di misure gestionali e amministrative nei confronti del lavoratore.

3.2.1.2 Visite non programmabili gestite amministrativamente a cura del Datore di Lavoro

Al verificarsi della necessità di sottoporre un dipendente a:

- a) visita medica di controllo idoneità per attività di sicurezza (in occasione di abilitazioni a nuove attività di sicurezza) o a seguito di assenza dal servizio per motivi di malattia di durata superiore ai 20 giorni continuativi (art. 8 Disp n. 55/2006 di RFI) o dopo rientro da infortunio sul lavoro (art. 10 Disp n. 55/2006 di RFI) o assenza prolungata per motivi diversi di durata superiore ai 180 giorni (art. 11 Disp n. 55/2006 di RFI);
- b) visita medica di sorveglianza sanitaria ai sensi del D.Lgs. 81/08 (ad esempio in occasione di un cambio di mansione che comporti l'esposizione a nuovi rischi che necessitino la sorveglianza sanitaria o a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai 60 giorni continuativi); per motivi di salute si intende l'assenza continuativa per malattia, periodi di inabilità assoluta per infortunio e di aspettativa per motivi di salute (art. 31 punto 9 lettera b CCNL Mobilità/Area AF del 22.03.22);
- c) visita di sorveglianza sanitaria richiesta dal lavoratore ai sensi dell'art. 41, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 81/2008¹.
- d) visita medica di controllo idoneità per il personale in fase di nuova abilitazione per rilascio di Licenza comunitaria ai sensi della COCS n.46/DT r.v.;
- e) visita medica di controllo idoneità a seguito di assenza per motivi di malattia di durata superiore ai 30 giorni continuativi o dopo rientro da infortunio sul lavoro per il personale di condotta in possesso di Licenza comunitaria ai sensi della COCS n.46/DT r.v.;
- f) visite mediche di controllo effettuate in occasione del verificarsi di gravi inconvenienti di esercizio che hanno pregiudicato o avrebbero potuto pregiudicare la sicurezza ferroviaria ai sensi della COCS 49/DT r.v.;
- g) ulteriore visita medica e/o valutazione psicologica se vi sono motivi ragionevoli per dubitare dell'idoneità fisica o psicologica del lavoratore (Articolo 4, comma 8 Disp. 55/06 e punto 4.7.2.2.3 Reg. 773/2019; art. 17, Allegato III p.3.1. D.lgs. n.247/2010; pt 7 nota ANSFISA n.0059345.23-12-2022, recepita con nota DT TRNIT-DTP\P\2023\00190227 del 13/03/2023);

la risorsa incaricata alla prenotazione delle visite mediche, su indicazione del competente RdI/DR, eventualmente anche raccordandosi con il RSPP:

- concorda con la UST/Presidio sanitario competente la prima data disponibile in cui sottoporre il dipendente a visita ed effettua la prenotazione secondo le modalità indicate in precedenza utilizzando l'applicativo VIME;

¹ Nel caso di visita di **sorveglianza sanitaria richiesta dal lavoratore** ai sensi dell'art. 41, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 81/2008, il lavoratore richiede la visita con il Medico Competente per il giudizio di idoneità alla mansione specifica assegnata dal Datore di Lavoro. La richiesta viene presentata per iscritto al proprio RSSP e RdI/DR, che provvede ad inoltrarla al MC per confermare che tale richiesta è correlata ai rischi professionali o alle condizioni di salute del lavoratore, suscettibili di peggioramento a causa dell'attività lavorativa svolta. In caso di conferma, il DdL tramite le risorse incaricate inserisce il nominativo nell'elenco dei dipendenti da inviare a visita, e provvede alla prenotazione della visita nel sistema VIME, informando inoltre DRUO/GP o RUT competente.

- predisporre la lettera di convocazione e la invia al RdI/DR.

Nel caso di eccezionali esigenze connesse all'esercizio ferroviario per le quali non possa essere effettuata una visita già programmata, la visita deve essere riprogrammata entro le 48 ore precedenti la data della visita prenotata.

Al verificarsi, inoltre, della necessità di effettuare una visita medica di idoneità per rientro da infortunio o da malattia:

- il dipendente segnala entro le ore 09:00 al competente RdI/DR, che si presenterà a visita presso la UST di competenza per il rientro in servizio;
- il RdI/DR ne fornisce immediata comunicazione alla risorsa incaricata alla prenotazione delle visite mediche che provvede alla prenotazione della relativa visita sul sistema VIME (vedi vademecum all. 1) entro le ore 10:00;
- non è dunque necessario che il dipendente presenti alla UST la credenziale prodotta da VIME ;
- l'UST accetterà il dipendente disponendo il prelievo della pratica dall'archivio, in attesa dell'arrivo della richiesta visita sul sistema VIME.

Accertamenti sanitari non prenotabili tramite VIME/nuova visita sanitaria

Qualora il DdL riscontrasse la necessità di sottoporre il lavoratore a ulteriori accertamenti sanitari non prenotabili tramite VIME perché non a catalogo, dovrà informare la struttura centrale di DRUO/Gestione del Personale e Contenzioso all'indirizzo di posta elettronica prestazionisanitarie@trenitalia.it.

In caso di nuova visita sanitaria e conseguente aggiornamento del catalogo visite da parte di Direzione Sanità di RFI, DRUO/Gestione del Personale e Contenzioso dopo esserne venuto a conoscenza, coinvolge la struttura DT/SIGSQ per le valutazioni necessarie ed in seguito provvede all'aggiornamento dell'elenco visite in VIME e dell'Allegato 1 alla presente CO.

3.2.1.3 Vaccinazioni antitetaniche

La Legge n. 419 del 20/03/1968 indica fra le categorie soggette a tale obbligo "operai e manovali" delle ferrovie e tale obbligo è stato esteso con il DM 22 marzo 1975 a tutto il personale che svolge attività di sicurezza dell'esercizio ferroviario: Condotta, Accompagnamento dei Treni, Preparazione dei Treni, Manutenzione Veicoli

A tale scopo viene istituito, per ciascun impianto, il Registro di impianto delle vaccinazioni antitetaniche (Allegato 2). Il RdI ne cura la conservazione e la gestione registrando di volta in volta i dati del dipendente che è stato sottoposto alla vaccinazione, il tipo di vaccinazione, la data di somministrazione e la successiva scadenza.

Le vaccinazioni sono effettuate presso i servizi di vaccinazione delle ASL o presso gli ambulatori dei medici di famiglia, oppure tramite l'UST/Presidio sanitario di competenza richiedendone, solo in quest'ultimo caso, la prenotazione tramite il sistema VIME.

L'annotazione sul registro deve essere effettuata solo dopo aver preso atto dell'avvenuta vaccinazione dal relativo certificato rilasciato dalla UST/Presidio sanitario (SAN140) o dalla struttura sanitaria esterna.

A ciascun lavoratore devono essere consegnati:

- a cura della struttura che effettua la vaccinazione, il tesserino delle vaccinazioni antitetaniche, che il dipendente deve portare con sé in occasione dei successivi richiami. Il medico registrerà l'avvenuta vaccinazione negli appositi spazi (data effettuazione del vaccino, tipo vaccino e serie);
- a cura del DdL una copia dell'informativa sul pericolo del tetano e sulla vaccinazione antitetanica (Allegato 3) di cui dovrà essere garantita la massima diffusione.

A ciascun RSPP/ASPP (Servizio di Prevenzione e Protezione) deve essere consegnata l'informativa di dettaglio sul pericolo del tetano e sulla vaccinazione antitetanica (Allegato 4).

L'informativa potrà essere utilizzata per i necessari corsi di formazione da erogare a tutto il personale interessato.

A seguito di prenotazione della *vaccinazione antitetanica effettuata presso UST/ Presidio Sanitario* il RdI/DR riceverà tramite Portale di Gruppo "WE" il modulo SAN 140 nel quale vengono specificate l'effettuazione del vaccino, la data del prossimo richiamo oppure la mancata effettuazione.

Il RdI/DR in caso di mancata effettuazione del vaccino informa il RSPP e, qualora non sia giustificata da motivato impedimento, ne dà comunicazione al RUT di competenza.

Ai fini del monitoraggio, il RdI aggiorna l'apposito registro con la data e il tipo di vaccinazione, nonché la data della successiva dose o richiamo.

Periodicamente il RSPP procede a monitorare e verificare il rispetto delle scadenze e tempistiche, inerente ai processi sopra descritti, stabilita dalla presente comunicazione organizzativa.

Controlli Chiave L.262/2005	N.A.
Controlli Chiave D.Lgs. 231/2001	Cod. H: <i>Gestione degli aspetti connessi alla salute e sicurezza sul lavoro</i>
Anticorruzione Strumenti di prevenzione	<u>Policy Anticorruzione</u> Area Sensibile: <i>"Selezione, assunzione, gestione e sviluppo del Personale"</i> <u>ABC System Management</u> Processo: <i>"Risorse Umane"</i>

	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA n.193.4/DT del 7 giu 2023 Procedura Gestione Amministrativa delle Visite Mediche e delle Prestazioni Sanitarie per il personale di Trenitalia	DT Pagina 20 di 27
---	--	--

3.3 Sottoprocesso 03 - Effettuazione visite e ricezione esiti

<i>Unità Organizzative Responsabili e Ruoli Coinvolti</i>	– DRUO/Gestione del Personale e Contenzioso – DRUO/Strutture di Risorse Umane Territoriali (RUT) – Impianto/Responsabile di Impianto (RdI) – Datore di Lavoro (DdL) – Delegato del Datore di Lavoro – Dirigente Responsabile di struttura organizzativa (DR) – Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP) – Struttura dirigenziale territoriale di Esercizio (SDT) di appartenenza del dipendente – Dipendente Trenitalia – RFI/Direzione Sanità/Unità Sanitarie Territoriali (UST) e loro Presidi sanitari/ Funzionario medico di Direzione Sanità/Unità Sanitarie Territoriali (UST) e loro Presidi sanitari con competenze valutative in ambito medico-legale e di medicina del lavoro (in quest’ultimo caso individuabile come Medico Competente -MC -)/Psicologo di Direzione Sanità/Unità Sanitarie Territoriali (UST) e loro Presidi sanitari nelle fattispecie previste
<i>Descrizione</i> Il dipendente si presenta all’UST/Presidio sanitario nel giorno ed orario stabiliti e nei casi di visite ai sensi del D.Lgs 81/08 consegna la scheda dati occupazionali al medico competente, come specificato in premessa. Nel caso in cui il dipendente non si presenti alla visita, il DdL-RdI/DR, per il tramite della risorsa incaricata della prenotazione delle visite mediche, o DRUO/GPC o RUT competente che risulti richiedente della visita, si attiverà per la riprenotazione, seguendo le indicazioni previste per le visite mediche non programmabili (vedere punto 3.2.1). Il medico di Direzione Sanità/UST/Presidio sanitario, dopo aver effettuato la visita medica e averne definito l’esito, inserisce i dati nel proprio sistema informativo, per l’aggiornamento di RUN. Gli esiti della visita sanitaria sono resi disponibili al dipendente, al suo responsabile e agli altri soggetti eventualmente autorizzati (es: RSPP) sul Portale di Gruppo “WE”. L’attestazione della presenza del dipendente presso la UST/ Presidio sanitario, il sistema RUN. Gli esiti delle visite sanitarie saranno forniti da RFI/Direzione Sanità/ Presidio sanitario, alle Unità previste dallo scambio informatico tra VIME e RUN di norma entro dieci giorni lavorativi dalla data dell’ultimo accertamento. Qualora venga superato il limite dei dieci giorni il RdI/RSPP dovrà informare la competente struttura centrale di DRUO/Gestione del Personale e Contenzioso (prestazionisanitarie@trenitalia.it). Dopo il ricevimento del San6 per le visite svolte ai sensi del D.Lgs. 247/2010-Dcreto n.8/2011, la documentazione prevista sarà inviata a cura del DdL/RdI ad ANSFISA entro massimo 10 giorni dal ricevimento, rispettando comunque il termine di almeno 30 giorni di anticipo rispetto la scadenza della visita. Sulla base dell’ambito di competenza DRUO/GPC o RUT forniscono opportuna informativa al RdI degli esiti riscontrati. Nella seguente tabella sono rappresentati gli esiti emessi da Direzione Sanità/UST, raggruppati nelle relative categorie di giudizio:	

Codice Esito	Descrizione ESITO	codice Categoria	Categorie GIUDIZI IDONEITA'/INIDONEITA'	Descrizione
I	IDONEO	I	IDONEO	Chi è in possesso di tutti i requisiti normativi necessari allo svolgimento dell'attività di sicurezza
J	IDONEO CON OBBLIGO DI PROTESI ACUSTICHE			
L	IDONEO CON OBBLIGO LENTI			
W	IN POSSESSO DEI REQUISITI PREVISTI PER			
Z	IDONEO IN ATTIVITÀ DI SICUREZZA			
D	IDONEO CON NOTE O LIMITAZIONI DEFINITIVE	L	IDONEO CON NOTE/LIMITAZIONI	Chi ha una limitazione definitiva allo svolgimento dell'attività di sicurezza
P	IDONEO CON NOTE O LIMITAZIONI TEMPORANEE	M	IDONEO CON NOTE/LIMITAZIONI TEMPORANEO	Chi ha una limitazione temporanea allo svolgimento dell'attività di sicurezza o necessità di controllo ravvicinato rispetto alla naturale scadenza del certificato.
E	NON IDONEO	N	NON IDONEO	Chi non è più in possesso in via definitiva dei requisiti normativi necessari allo svolgimento dell'attività di sicurezza
G	IDONEO ALLE ATTIVITA' NON DI SICUREZZA DEFINITIVO			
Y	NON IN POSSESSO DEI REQUISITI PREVISTI PER			
H	IDONEO ALLE ATTIVITA' NON DI SICUREZZA TEMPORANEO	P	NON IDONEO TEMPORANEO	Chi non è più in possesso in via temporanea dei requisiti normativi necessari allo svolgimento dell'attività di sicurezza o senza emissione di Giudizio
V	NON IDONEO IN VIA TEMPORANEA			
3	PARERE MEDICO LEGALE POSITIVO	K	Vedere la Documentazione Allegata	In genere l'oggetto è rappresentato da questioni non concernenti l'idoneità al lavoro (estensione comparto, questioni previdenziali, ecc) Se viene prodotto il SAN 6 viene emesso un corrispettivo edito di Idoneità o inidoneità
4	PARERE MEDICO LEGALE NEGATIVO			
9	NON IDONEO MOMENTANEAMENTE	Z	INIDONEITÀ MOMENTANEA	Inidoneità momentanea per fermare subito il lavoratore in attesa del parere definitivo
X	CASI SENZA EMISSIONE DI GIUDIZIO	0	Senza giudizio	

Nel caso il medico di Direzione Sanità/UST/ Presidio sanitario, ritenga di sospendere temporaneamente il dipendente dall'attività di sicurezza/mansione, in attesa del completamento degli accertamenti sanitari, emette un "esito di temporanea inidoneità" inserendo i dati nel proprio sistema informativo (Categoria esiti "P").

Nel caso di esito di inidoneità temporanea o definitiva (Categoria "P" e "N") che determina la sospensione del dipendente da attività connesse alla sicurezza dell'esercizio/mansione il sistema informativo RUN predispone un avviso "ALERT" automatico che viene inviato via e-mail al DR/RdI della risorsa; quest'ultimo fornisce tempestiva comunicazione a DRUO/GPC o RUT competente al fine di avviare le opportune azioni gestionali.

Il sistema RUN individua il destinatario dell'Alert utilizzando l'allocazione organizzativa del dipendente e la gerarchia delle Unità Organizzative.

In caso di personale utilizzato presso altri impianti, l'avviso viene comunque ricevuto dalla Struttura di appartenenza che dovrà farsi carico di allertare tempestivamente la struttura di utilizzazione.

Il sistema RUN consente a RdI/DdL/DR o DRUO/GPC e RUT competente di verificare costantemente i requisiti di idoneità del personale di appartenenza, sulla base dell'aggiornamento del sistema informativo della UST/ Presidio sanitario.

In caso di esito diverso da quello di idoneità o che modifichi la precedente condizione di idoneità/inidoneità per personale in utilizzo temporaneo presso altri impianti, il RdI di appartenenza deve fornire immediata comunicazione al RdI utilizzatore.

Al rientro in servizio del dipendente dalla visita medica, prima della sua utilizzazione, il RdI verifica lo stato di idoneità del dipendente tramite:

- apposita transazione sul sistema RUN-AGENDE (per le abilitazioni di sicurezza) o tramite le visualizzazioni dei dati sanitari sul portale “WE”;
- eventuale ricezione del messaggio di posta elettronica di “ALERT”, in caso di esito di inidoneità temporanea o definitiva.
- eventuale ricezione di comunicazione (via telefono – e-mail) dalla UST, nel caso di esito diverso da quello di idoneità o che modifichi la precedente condizione di idoneità/inidoneità
- eventuale ricezione di comunicazione da parte di DRUO/GPC o RUT competente.

Il RdI:

- *in caso di inidoneità temporanea, parziale o definitiva in ambito attività di sicurezza*, informa tempestivamente la competente struttura di RUT che si attiverà per l'adozione dei provvedimenti del caso;
- *nel caso di visite di sorveglianza sanitaria ai sensi del D.Lgs 81/08*, trasmette la relativa documentazione al DdL e al RSPP dell'Unità Produttiva di appartenenza del dipendente;
- *nel caso delle altre visite mediche* scarica mensilmente la reportistica dal sistema AGENDE contenente il riepilogo degli esiti delle visite mediche e compila l'Allegato 5 solo per le visite delle risorse che vengono utilizzate dalla struttura ma che sono assegnate ad altro impianto, secondo quanto riportato nei moduli di esito visita; trasmette mensilmente tali report al DdL dell'impianto utilizzatore.

Il RUT di competenza, con l'eventuale coinvolgimento di DRUO/GPC, d'intesa con il RdI/DdL:

- nei casi di inidoneità o laddove necessario per i casi di idoneità con note/ limitazioni ai sensi della Medicina Legale, individua possibili soluzioni di ricollocamento del dipendente tenendo conto delle informazioni contenute nell'All. 17 “modulo attività residue” allegato alla convenzione prestazioni sanitarie gestita dalla DRUO/GPC. Si specifica che nei casi di inidoneità temporanea la richiesta di emissione dell'allegato 17 deve essere esplicitamente richiesta dal RUT alla UST di riferimento.
- nei casi di inidoneità o idoneità con limitazioni nell'ambito della Medicina del Lavoro, individua possibili soluzioni in coerenza alle indicazioni espresse dal Medico competente.

effettua la richiesta di nuova visita sanitaria, qualora la soluzione di ricollocamento del lavoratore lo richieda.

Controlli Chiave L.262/2005	N.A.
Controlli Chiave D.Lgs. 231/2001	Cod. H: Gestione degli aspetti connessi alla salute e sicurezza sul lavoro
Anticorruzione Strumenti di prevenzione	<u>Policy Anticorruzione</u> Area Sensibile: <i>“Selezione, assunzione, gestione e sviluppo del Personale”</i> <u>ABC System Management</u> Processo: <i>“Risorse Umane</i>

	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA n.193.4/DT del 7 giu 2023 Procedura Gestione Amministrativa delle Visite Mediche e delle Prestazioni Sanitarie per il personale di Trenitalia	DT Pagina 23 di 27
---	--	--

3.4 Sottoprocesso 04 - Aggiornamento dati a sistema, reporting e monitoraggio

Unità Organizzative Responsabili e Ruoli Coinvolti	– DRUO/Gestione del Personale e Contenzioso – Responsabile Servizi di Prevenzione e Protezione (RSPP) – Impianto/ Responsabile di Impianto (RdI) – Datore di Lavoro (DdL) – Dirigente Responsabile di struttura organizzativa (DR) – Struttura Dirigenziale Territoriale (SDT) di appartenenza del dipendente – Dipendente Trenitalia – RFI/Direzione Sanità/Unità Sanitarie Territoriali (UST) e loro Presidi sanitari/ Funzionario medico di Direzione Sanità/Unità Sanitarie Territoriali (UST) e loro Presidi sanitari con competenze valutative in ambito medico-legale e di medicina del lavoro (in quest’ultimo caso individuabile come Medico Competente -MC -)/Psicologo di Direzione Sanità/Unità Sanitarie Territoriali (UST) e loro Presidi sanitari nelle fattispecie previste
Descrizione <i>Nel caso di visite mediche di revisione/controllo e conversione per il personale impiegato in attività di sicurezza dell’esercizio ferroviario: entro 5 giorni dalla data di ricezione della documentazione inerente la visita, la SDT assicura:</i> – l’archiviazione della documentazione; – la verifica dei dati aggiornati del dipendente a sistema RUN/AGENDE (eventuali limitazioni o inidoneità), con particolare riguardo alla “data di scadenza prossima visita” secondo quanto previsto dalla COCS n.41/DT r.v. Il DdL, per il tramite della risorsa incaricata alla prenotazione delle visite mediche, utilizzando l’apposito report sul sistema VIME “Gestione Visite Mediche”, procede mensilmente alla rendicontazione delle prestazioni sanitarie effettuate dalla UST di riferimento sul personale di propria competenza, specificando: – CID, – Nome e Cognome, – tipologia di visita effettuata, – motivo della visita, – giorno/i di effettuazione. <i>Nel caso di visite mediche di sorveglianza sanitaria ai sensi del D.Lgs 81/08 e di visite mediche per il conseguimento/mantenimento di certificazioni tecnico/specialistiche non connesse direttamente con l’esercizio ferroviario entro 5 giorni dalla data di ricezione della documentazione inerente la visita, il RdI o il RSPP procede all’archiviazione della documentazione.</i> Ai fini delle verifiche di congruenza dei corrispettivi economici relativi alle visite sanitarie effettuate da Direzione Sanità di RFI per il personale Trenitalia, DRUO/Gestione del Personale e Contenzioso: - effettua un controllo di congruenza confrontando i report di dettaglio ricevuti da Direzione Sanità di RFI con la reportistica disponibile nel sistema RUN-TM; - invia ai Datori di Lavoro e ai Controller Direzionali, trimestralmente, l’elenco delle visite effettuate al personale dell’Unità Produttiva di riferimento, evidenziando i costi sostenuti. I Datori di Lavoro, entro 15 giorni dalla ricezione, comunicano a DRUO/Gestione del Personale e Contenzioso (indirizzo mail prestazionisanitarie@trenitalia.it.) eventuali disallineamenti e/o incongruenze riscontrati, indicando la	

	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA n.193.4/DT del 7 giu 2023 Procedura Gestione Amministrativa delle Visite Mediche e delle Prestazioni Sanitarie per il personale di Trenitalia	DT Pagina 24 di 27
---	--	--

descrizione dell'anomalia ed ogni ulteriore elemento utile di dettaglio, per il successivo seguito con Direzione Sanità di RFI e definizione finale delle prestazioni rese.	
Controlli Chiave L.262/2005	N.A.
Controlli Chiave D.Lgs. 231/2001	<i>Cod. H: Gestione degli aspetti connessi alla salute e sicurezza sul lavoro</i> <i>Cod. H: Gestione degli aspetti connessi alla salute e sicurezza sul lavoro</i>
Anticorruzione Strumenti di prevenzione	<u>Policy Anticorruzione</u> Area Sensibile: <i>"Selezione, assunzione, gestione e sviluppo del Personale"</i> <u>ABC System Management</u> Processo: <i>"Risorse Umane"</i>

4. Documentazione di Riferimento

RIFERIMENTI NORMATIVI:

- D.Lgs n. 247/2010 “Attuazione della direttiva 2007/59/CE relativa alla certificazione dei macchinisti addetti alla guida di locomotori e treni sul sistema ferroviario della Comunità”
- Decreto ANSF n. 8/2011 concernente "Licenze dei macchinisti addetti alla guida di locomotori e treni sul sistema ferroviario dell'Unione Europea";
- D.Lgs. 81/2008 “Testo Unico della Sicurezza Lavoro” e s.m.i;
- Provvedimento della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano del 16/03/2006, ai sensi dell'art. 15 della legge 30/03/2001, n. 125. “Legge quadro in materia di alcol e di problemi alcol correlati”;
- Conferenza Unificata Stato-Regioni, Città e Autonomie Locali – Provvedimento del 30 ottobre 2007 Intesa, ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 05/06/2003, n.131, in materia di accertamento di assenza di tossicodipendenza;
- Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano – Provvedimento del 18/09/2008;
- Accordo, ai sensi dell'art. 8, comma 2 dell'Intesa in materia di accertamento di assenza di tossicodipendenza, perfezionata nella seduta della Conferenza Unificata del 30/10/2007, sul documento recante “Procedure per gli accertamenti sanitari di assenza di tossico dipendenza o di assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope in lavoratori addetti a mansioni che comportano particolari rischi per la sicurezza, l'incolumità e la salute di terzi”;
- Legge n. 419 del 20/03/1968 - Vaccinazione antitetanica obbligatoria;
- DM 22/03/1975 Ministero Sanità - Estensione dell'obbligo della vaccinazione antitetanica ad altre categorie di lavoratori;
DM 01/03/1974 e s.m.i;
- Regolamento Di Esecuzione (UE) 2019/773 della Commissione del 16 maggio 2019 relativo alla specifica tecnica di interoperabilità per il sottosistema «Esercizio e gestione del traffico» del sistema ferroviario nell'Unione europea e che abroga la decisione 2012/757/UE;
- Regolamento UE 2015/995 dell'8/06/2015 recante modifica della decisione 2012/757/UE relativa alla specifica tecnica di interoperabilità concernente il sottosistema “Esercizio e gestione del traffico” del sistema ferroviario nell'Unione europea (per memoria);
- Nota ANSF n. 000196/2017 del 10/01/2017 – “Attuazione dei punti 4.6 e 4.7 della Specifica Tecnica di Interoperabilità Esercizio e Gestione del Traffico emanata in allegato alla decisione 2012/757/UE e modificata

	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA n.193.4/DT del 7 giu 2023 Procedura Gestione Amministrativa delle Visite Mediche e delle Prestazioni Sanitarie per il personale di Trenitalia	DT Pagina 25 di 27
---	--	--

dal Regolamento (UE) 2015/995 della Commissione dell'8 giugno 2015. Adozione dei principi introdotti dalla Specifica Tecnica di Interoperabilità Esercizio anche nelle norme nazionali.” e successive modifiche e integrazioni;

- Nota ANSF n. 0010338/2017 del 27/09/2017: “Modifiche alle norme nazionali, indicazioni e chiarimenti per l'invio a visita medica e per la certificazione dei requisiti. Applicazione della nota ANSF 196/2017 del 10/01/2017 "Attuazione dei punti 4.6 e 4.7 della Specifica Tecnica di Interoperabilità Esercizio e Gestione del traffico emanata in allegato alla decisione 2012/757/UE e modificata dal Regolamento (UE) 2015/995 della Commissione dell'8 giugno 2015. Adozione dei principi introdotti dalla Specifica Tecnica di Interoperabilità Esercizio anche nelle norme nazionali”;
- Nota ANSF n. 002161/2014 del 24/03/2014: Scadenza visite sanitarie ai sensi del D.Lgs. 247/2010;
- Nota ANSFISA n. 0028455/ 2021 del 09/12/2021: Certificazione medico-legale dell'idoneità psico-fisica allo svolgimento di attività di sicurezza della circolazione ferroviaria;
- Nota ANSFISA n.0059345.23-12-2022: Equiparazione dei requisiti fisici speciali della Disposizione RFI 55/2006 tra visita di assunzione e visita di revisione – Ulteriore estensione dei principi introdotti nella normativa europea per la “Condotta dei treni” e l’“Accompagnamento dei treni” alle altre attività di sicurezza.
- UNI EN 273.
- D.M. 8 maggio 1997, n. 187, Regolamento recante modalità applicative delle disposizioni contenute all'articolo 2, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335, concernenti l'attribuzione della pensione di inabilità ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche iscritti a forme di previdenza esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria.
- Legge 8 agosto 1995, n. 335 Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare.
- Messaggio INPS n. 33936 del 22.10.2004 Fondo speciale dipendenti della Ferrovie dello Stato S.p.A. Pensione di inidoneità al servizio ferroviario in genere.

DOCUMENTI DI GRUPPO:

- Policy Anticorruzione del Gruppo FS Italiane
- Disposizione n. 55 del 28 nov 2006 di RFI SpA;
- Disposizione n. 14 del 17 apr 2007 di RFI SpA;
- Prescrizione n. 939 del 2 mag 2007 di RFI SpA;
- Prescrizione n. 1934 del 4 lug 2007 di RFI SpA;
- Nota del 17/04/2007 (prot. DCRU/DPPG/U/0000299) di FS SpA e allegati;
- Nota della Direzione Sanità di RFI prot. n.279 del 04/11/2008 “Sorveglianza sanitaria e di rischio”;
- Nota della Direzione Sanità di RFI prot. n.417 del 04/09/2009 “Decreto Legislativo 3 agosto 2009, n. 106”;
- Nota FS-DCRUO-GPSL\A0011\P\2015\000174 del 27/04/2015 “Dati sanitari – Visualizzazione dei referti medici e certificati di idoneità attraverso il Portale di Gruppo “WE” – nuove funzionalità;
- Indirizzi aziendali in materia di prevenzione dal consumo di alcol e sostanze psicotrope sui luoghi di lavoro FS-DCRUO\A0011\P\2014\0000364 del 8/10/2014 e unito “Protocollo per la tutela della salute e della sicurezza rispetto al consumo di sostanze alcoliche e psicotrope per il personale del Gruppo FSI” definito dalla Direzione Sanità di RFI.

DOCUMENTI DI TRENITALIA (revisione vigente):

- Modello di Organizzazione Gestione e Controllo di Trenitalia ai sensi del D.Lgs. 231/2001;
- Anti Bribery&Corruption management System di Trenitalia
- COCS n. 41/DT r.v. “Gestione dei flussi informativi interni all'impresa ferroviaria e da/per ANSFISA relativi ai processi di monitoraggio, rilascio, mantenimento e revoca dei titoli abilitativi al fine dello svolgimento delle attività di sicurezza di esercizio”;

	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA n.193.4/DT del 7 giu 2023 Procedura Gestione Amministrativa delle Visite Mediche e delle Prestazioni Sanitarie per il personale di Trenitalia	DT Pagina 26 di 27
---	--	--

- CO n. 348/DRUO r.v. “Procedura per l’accertamento e la sussistenza nel tempo dei requisiti per la qualificazione professionale del personale che svolge attività con impatto sulla sicurezza dell’esercizio”;
- CO n. 457/DT r.v. “Tutela della Salute e della Sicurezza rispetto al consumo di sostanze alcoliche e psicotrope per il personale di Trenitalia”;
- COCS n. 61/DT r.v. “Processi organizzativi per l’erogazione della formazione, la certificazione del requisito professionale e il mantenimento delle competenze del personale che svolge attività di Preparazione dei Treni e Accompagnamento dei Treni”;
- COCS n. 46/DT r.v. “Processi organizzativi per l’acquisizione ed il mantenimento della Licenza Comunitaria e del Certificato Complementare per lo svolgimento delle attività di condotta”;
- COCS n. 20/DT r.v. “Acquisizione, mantenimento e gestione delle competenze per le Abilitazioni del personale di manutenzione che opera sugli organi di Sicurezza dei veicoli ferroviari”;
- COCS n. 49/DT r.v. “Procedura da adottare nei confronti del personale di Trenitalia che svolge mansioni di sicurezza dell’esercizio, in presenza di gravi inconvenienti di esercizio che hanno pregiudicato o avrebbero potuto pregiudicare la sicurezza ferroviaria”.
- DOCS n. 55/DT-SIGSQ r.v. “Processi operativi per il conferimento e mantenimento delle abilitazioni interne negli impianti di Trenitalia”
- Specifica Trenitalia /UTMR n. 308177
- C.O.I. /AD n. 25 del 5 ago 2021
- Nota DT TRNIT-DTP\P\2023\00190227 del 13/03/2023 - Equiparazione dei requisiti fisici speciali previsti dalla Disposizione RFI 55/2006 per la visita di assunzione e la visita di revisione e estensione di ulteriori principi alle attività di sicurezza diverse da “Condotta dei treni” e “Accompagnamento dei treni”.

5. Definizioni e Abbreviazioni

ANSFISA	Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture Stradali ed Autostradali
ASL	Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente
ASPP	Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione
COCS	Comunicazione Operativa per il Certificato di Sicurezza
DdL	Datore di Lavoro
DR	Responsabile di struttura organizzativa dirigenziale alle cui dipendenze non opera personale impiegato in attività connesse con la sicurezza dell’esercizio ferroviario riportate nella Tabella allegato 1 alla Disposizione n. 55 del 28 nov 2006 di RFI SpA
DRUO	Direzione Risorse Umane e Organizzazione
DVR	Documento di Valutazione dei Rischi
GP	Gestione del personale
MC	Medico Competente
FM	Funzionario Medico
RdI	Responsabile di Impianto
RSPP	Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione
RUT	Struttura territoriale di Risorse Umane
RUN	Risorse Umane Network
RUN - AGENDE	Applicativo aziendale per la gestione del mantenimento delle competenze fisiche e professionali del personale abilitato ad attività di sicurezza
RUN -TM	Sistema Informativo RUN TIME MANAGEMENT

 TRENITALIA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA n.193.4/DT del 7 giu 2023 Procedura Gestione Amministrativa delle Visite Mediche e delle Prestazioni Sanitarie per il personale di Trenitalia	DT Pagina 27 di 27
---	--	-------------------------------------

SAN6	Certificato di idoneità fisica/Certificato delle capacità psicoattitudinali
SDT	Struttura dirigenziale territoriale di esercizio alle cui dipendenze opera personale impiegato in attività connesse con la sicurezza dell'esercizio ferroviario riportate nella Tabella allegato 1 alla Disposizione n. 55 del 28 nov 2006 di RFI SpA
SPTD	Strutture di Presidio Tecnico Direzionale
UP	Unità Produttiva
UST	Unità Sanitaria Territoriale della Direzione Sanità di RFI SpA
VIME	Sistema informatico Gestione Visite Mediche

6. Allegati

I sottoelencati allegati possono essere aggiornati e trasmessi nei modi d'uso senza necessità di revisione della CO.

Allegato 1 - Elenco nominativi del personale da inviare a visita medica.

Allegato 2 – Registro di impianto delle vaccinazioni antitetaniche.

Allegato 3 - Informazione sul pericolo “Il tetano e la vaccinazione antitetanica”.

Allegato 4 – La Vaccinazione Antitetanica.

Allegato 5 - Report esiti visite mediche.